

Ein autistischer Student / eine autistische Studentin in Ihrer Praxis

Für Hausärzt:innen, Hochschul-Gesundheits- und Psychotherapiedienste — Versorgung eines autistischen Studierenden (etwa 18–25 Jahre).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit einer Studierenden/eines Studierenden in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Das Studium ist ein *gewaltiger* Übergang: neue Autonomie, weniger Struktur, überall Großraum, Gruppenarbeit, sozialer Druck und gestörte Routinen. Viele autistische Studierende blühten unter der Vorhersagbarkeit der Schule auf und **prallen dann an eine Wand** — Burnout, Angst oder Krise im ersten oder zweiten Jahr. Ihre fokussierten Interessen sind eine echte Stärke; das System um sie herum ist meist das Problem.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
War „gut“, kann nun nicht teilnehmen, sich waschen, essen oder funktionieren	Autistisches Burnout durch die kumulative Last einer vielspurigen, unvorhersehbaren Umwelt
Angst, Depression, Schlaf-Zusammenbruch, gestörtes Essen	Häufige Ko-Vorkommen ; auch Signale von Überlastung, nicht nur primäre Erkrankung
Überspringt Vorlesungen, verpasst Fristen; wirkt „faul“	Autistische Trägheit + exekutive Last unter chronischer Erschöpfung
Erst jetzt, in der Krise, diagnostiziert	Das Studium ist ein häufiger Punkt später Erkennung („verlorene Generation“)
Bevorzugt E-Mail; meidet Anrufe, Blickkontakt, Gruppen-Settings	Eingekanalige, wörtliche Kommunikation; schriftlicher Kontakt senkt die Last

Versuchen Sie dies

- **Bieten Sie Online-/Telefon- oder schriftlich-zuerst-Termine**; erlauben Sie eine Begleitperson und ein sensorisches Set.
- **Screenen Sie gezielt auf autistisches Burnout** — Erschöpfung, Verlust zuvor gehaltener Kompetenzen, verminderte Reiztoleranz — und behandeln Sie es als von Depression verschieden.
- **Reduzieren und strukturieren Sie**: setzen Sie sich für Anpassungen über den universitären Behindertenservice ein (ruhiger Prüfungsraum, Vorhersagbarkeit des Stundenplans, schriftliche Anweisungen).
- **Fragen Sie nach Interessen und Erholung** — schützen Sie den Zugang; Ruhe und „Dinge auf autistische Art tun“ sind Teil der Erholung.
- **Planen Sie Kontinuität** über die Ferien und den Übergang ins Erwachsenen-/Berufsleben.

Vermeiden Sie dies

- Standardmäßig „typischer Studierendenstress/-angst“ und damit Burnout oder eine Ersterkennung des Autismus übersehen.

- Allgemeine Sozialkompetenz- oder „Zieh-es-durch“-Ansätze empfehlen, die Masking erhöhen.
- Annehmen, Engagement = Blickkontakt und verbale Gewandtheit.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Screenen Sie direkt auf Suizidalität und schweres Burnout. Verweisen Sie an den **universitären Behinderten-/Beratungsservice**, Mentoring und autistische Studierenden-Communities. Erwägen Sie eine **vorübergehende Reduktion der Studienlast** oder einen Studienunterbruch als legitimen, evidenzangemessenen Erholungsschritt — kein Scheitern. Behandeln Sie begleitende ADHD, Angst, Schlaf- und GI-Zustände.

Wenn der/die Studierende eine Frau ist

Frauen und Studierende marginalisierter Geschlechter sind unter den spät-erkannten überrepräsentiert und masken oft stark. Ein „leistungsstarkes, oberflächlich geselliges“ Erscheinungsbild mit privatem Zusammenbruch ist ein Schlüsselmuster — fragen Sie nach der Lücke zwischen öffentlicher Leistung und privater Erschöpfung.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — das **Monotropismus**-Dossier und der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.3–3.4 & 4). Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Knight (2021, *Tunnel statt Aufgaben*); AASPIRE AHAT. Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.